



cancer du sein

Pr Ag Bouchahda Haifa

*Service de gynécologie
obstétrique*

EPS Tahar Sfar Mahdia

RESIDANAT 2025

Preamble

Un problème majeur de santé dans le monde

1^{ier} cancer chez la femme

1^{ière} cause de décès chez la femme

En Tunisie ; quelques particularités:

- ❖ avec un âge moyen inférieur d'une dizaine d'année à celui observé chez la femme occidentale .
- ❖ Un diagnostic à un stade tardif avec une taille tumorale importante.
- ❖ Taux de femmes jeunes est de 11% (en Europe 2 à 5 %)
- ❖ Plus de cancer inflammatoire



objectifs

- 1. Décrire le système de drainage lymphatique du sein.
- 2. Décrire les particularités anatomopathologiques des tumeurs malignes du sein.
- 3. Expliquer le mode d'extension du cancer du sein.
- 4. Identifier à partir des données de l'anamnèse les sujets à risque de développer un cancer du sein.
- 5. Réunir les éléments cliniques et paracliniques permettant de poser le diagnostic du cancer du sein en fonction du degré d'évolution.
- 6. Evaluer sur des arguments cliniques et paracliniques le pronostic du cancer du sein.
- 7. Planifier la stratégie thérapeutique du cancer du sein en fonction du stade TNM et des facteurs histo-pronostiques.
- 8. Indiquer les modalités de surveillance post-thérapeutique d'un cancer du sein.
- 9. Elaborer la stratégie du diagnostic précoce du cancer du sein.
- 10. Expliquer les moyens de prévention du cancer du sein.



1. Décrire le système de drainage lymphatique du sein.

QCM1

Quelle est la principale voie de drainage lymphatique du cancer du sein, vers laquelle convergent les collecteurs de tous les quadrants mammaires ?

- A. Les nœuds lymphatiques para-sternaux (mammaires internes)
- B. Les nœuds lymphatiques axillaires
- C. Les nœuds lymphatiques supra-claviculaires
- D. Le réseau lymphatique sous-aréolaire
- E. Les noeuds lymphatique sous claviculaires berg III

QCM2

L'envahissement lymphatique du cancer du sein :

- A. Progresse en règle sans sauter de relais d'un groupe ganglionnaire à l'autre
- B. Ne se fait jamais au groupe mammaire interne dans les tumeurs des quadrants externes de la glande
- C. Est un facteur aggravant le pronostic
- D. Est l'un des éléments de la définition de la poussée évolutive
- E. Implique formellement un traitement adjuvant par le Tamoxifene (Nolvadex)

2. Décrire les particularités anatomopathologiques des tumeurs malignes du sein

QCM3

Quelle caractéristique microscopique est typique du carcinome lobulaire infiltrant, le différenciant du carcinome canalaire ?

- A. Une lésion eczématiforme de l'épithélium mamelonnaire
- B. La formation de structures tubulaires ou glandulaires
- C. Des cellules isolées en travées monocellulaires (aspect en file indienne)
- D. Une prolifération canalaire centrée par une nécrose tumorale
- E. La présence de cellule en bague à chaton

QCM4

Un cancer du sein classé 'Triple négatif' (basal-like) est défini par quelles caractéristiques immunohistochimiques ?

- A. RE-/RP- et Her2-
- B. RE+/RP- et Her2+
- C. RE+/RP+ et Her2-
- D. RE-/RP- et Her2+
- E. Ki 67 < 20%

QCM5

Sur le plan histologique le cancer du sein est :

A-Rapidement métastatique

B- Souvent bilatéral

C-Dominés par les adénocarcinomes

D-Les sarcomes sont fréquents

E-Lymphophile

QCM6

Les carcinomes :

- A- Représentent 98% des tumeurs mammaires
- B- peuvent intéresser les canaux ou les lobules
- C- Sont toujours infiltrants
- D- Ne donnent pas de métastases
- E- Les ganglions sus claviculaires sont toujours atteints

QCM7

Quelles sont les propositions justes concernant le cancer du sein ?

- A. Le cancer canalaire infiltrant est le plus fréquent
- B. La maladie de Paget du mamelon peut être une atteinte intraépidermique d'un cancer infiltrant
- C. La forme lobulaire donne moins d'atteintes bilatérales
- D. Le grade SBR est un facteur pronostic du cancer
- E. En Tunisie il est le plus souvent peu différencié

QCM8

Les carcinomes non infiltrants :

- A. Sont limités par une membrane basale intacte
- B. Peuvent être canalaire et lobulaire
- C. Souvent asymptomatique
- D. Touchent surtout les femmes jeunes
- E. Sont de mauvais pronostic

QCM9

Quelle est la principale différence entre un carcinome canalaire in situ (CCIS) et un carcinome lobulaire in situ (CLIS) en termes de potentiel d'évolution ?

- A. Le CCIS ne donne jamais de métastases, contrairement au CLIS.
- B. Le CLIS est accessible au dépistage par mammographie, alors que le CCIS ne l'est pas.
- C. Le CCIS est considéré comme une lésion précancéreuse qui progresse souvent vers l'infiltration, tandis que le CLIS progresse rarement.
- D. Le CCIS est toujours unicentrique, alors que le CLIS est toujours multicentrique.
- E. Le CCIS a une probabilité plus élevée que le CLIS d'être bilatéral .

QCM 10

Comment est défini un cancer du sein 'multicentrique' ?

- A. Présence d'au moins deux foyers tumoraux dans le même quadrant du sein.
- B. Présence de foyers tumoraux dans les deux seins simultanément.
- C. Présence d'au moins deux foyers dans des quadrants différents ou distants de plus de 5 cm.
- D. Présence d'une tumeur principale et d'emboles lymphatiques péri-tumoraux.
- E. présence de métastase à distance

QCM11

Un score SBR total de 8 est

- A. Un Grade III,
- B. Un grade I
- C. Facteur de pronostic intermédiaire
- D. A un impact direct sur le choix des traitements.
- E. Indique une chimiothérapie adjuvante

QCM 12

Le carcinome canalaire in situ

A- Accessible au dépistage

B- Peut se manifester par un écoulement sanguinolent

C- Peut être multicentrique

D- Peut être bilatéral

E- N'évolue pas vers un carcinome infiltrant

QCM 13

Le carcinome lobulaire in situ

A- est moins fréquent que le cancer canalaire in situ

B- Est accessible au dépistage

C- Découvert par biopsie pour dystrophie mammaire

D- Le plus souvent multicentrique

E- Se voit dans la maladie de paget

QCM 14

- Le grade histopronostique de SCARFF, BLOOM et RICHARDSON (SBR) tient compte de :
 - A. Degré de différenciation
 - B. Degrés de mitoses
 - C. L'infiltration tumorale
 - D. L'étendue tumorale
 - E. Degré d'anisonucléose

QCM 15

Un cancer du sein RE+/RP+, Her2- et avec un Ki67 < 20% correspond à quel sous-type moléculaire ?

A.Luminal A

B.Luminal B

C.Triple négatif

D.Her2

E.Basal

QCM 16

Une tumeur phyllode maligne

- A. Associe une composante conjonctive et une composante épithéliale
- B. Est un Carcinome
- C. A un haut potentiel de récurrence locale
- D. Est très lymphophile
- E. Peut nécessiter un curage ganglionnaire

QCM 17

La maladie de Paget

- A. Indique une mastectomie
- B. Se manifeste par une atteinte mamelonnaire
- C. Peut s'associer à un carcinome infiltrant sous jacent
- D. Peut s'associer à un CCIS sous jacent
- E. Peut s'associer à un CLIS sous jacent

QCM18

- Le grade histopronostic de SCARF et BLOOM est important a considérer en cas de :

A - Cancer du col

B - Cancer de l'endomètre

C - Cancer de l'ovaire

D - Cancer du sein

E - Dans tous ces cancers

QCM 19

La maladie de Paget du sein :

- A- Se transmet par l'allaitement
- B - Est une atteinte du mamelon souvent associée à un cancer méconnu sous-jacent
- C - Est un comédo-carcinome
- D - Est plus fréquente chez les fumeuses
- E - Apparaît avant 40 ans

QCM 20

- Le type histologique du cancer du sein le plus fréquent est :

A - Cancer spino-cellulaire

B - Les tumeurs phylloides

C – Carcinome

D - Le lymphome

E – Sarcomes

3. Expliquer le mode d'extension du cancer du sein.

QCM 21

Le cancer du sein :

- A. D'emblée une maladie générale
- B. L'atteinte ganglionnaire est fréquente
- C. L'atteinte ganglionnaire est de mauvais pronostic
- D. Peut-être révélé par des métastases
- E. Les métastases sont fréquentes

QCM 22

Face à un cancer du sein T3, il faut systématiquement demander :

- A. Scintigraphie osseuse
- B. Echographie abdominopelvienne
- C. TDM cérébral
- D. Rx thorax
- E. Rx bassin

QCM 23

Le bilan d'extension chez une femme atteinte d'un cancer du sein :

- A. comporte un examen clinique
- B. est indiqué pour les tumeurs cT2N0.
- C. est indiqué pour les tumeurs potentiellement agressives.
- D. comporte un scanner thoraco-abdomino-pelvien et une scintigraphie osseuse
- E. comporte un PET-scan .

4. Identifier à partir des données de l'anamnèse les sujets à risque de développer un cancer du sein

QCM 24

Lequel des facteurs de risque suivants est lié à une hyperœstrogénie endogène prolongeant l'exposition hormonale ?

- A. Une radiothérapie thoracique à un jeune âge
- B. Une première grossesse tardive (>35 ans)
- C. Une mutation du gène BRCA1
- D. L'allaitement prolongé
- E. une obésité

QCM 25

Le facteur de risque le plus important pour le cancer du sein est

- A. l'âge
- B. le sexe
- C. l'obésité
- D. la nulliparité
- E. la ménopause tardive

QCM 26

Les facteurs de risque de cancer du sein :

A- Pas d'antécédents familiaux de cancer mammaires

B- La dystrophie fibro-kystique contenant une hyperplasie avec atypie

C-Mutation de BRCA 1 et 2

D- Ménarche tardive

E-Régime pauvre en graisse

QCM 27

Parmi le(s) facteur(s) suivant(s) le(s)quel(s) favorisent) le cancer du sein ?

A- Antécédent de cancer du sein controlatéral

B- Premières règles tardives

C- Age précoce de la première grossesse

D- Ménopause tardive

E- Antécédent familial de cancer du sein

QCM 28

Parmi les antécédents suivants, lesquels doivent être considérés comme facteurs de risque du cancer du sein ?

- A- Cancer du sein chez la mère
- B- Première règles précoces avant 10 ans
- C- Grossesse avant 20 ans
- D- Allaitement maternel des 2 enfants
- E- Hyperprolactinémie

QCM 29

Madame D, vous consulte pour une tumeur du sein. Quels) est (sont) le(s) élément(s) qui vous fait (font) penser qu'elle est à haut risque de cancer du sein ?

A- Elle a été opérée d'une mastopathie bénigne

B- Elle a eu 4 enfants

C- Elle était sous pilule

D- Sa mère a eu un cancer du sein

E- Elle a eu ses premières règles tard

QCM 30

Le cancer du sein :

A-Augmente avec la prise de pilule

B-Augmente avec l'âge

C-Augmente chez les obèses

D-Hormonodépendant

E-Est dominé par les sarcomes

QCM 31

Le cancer du sein :

- A. Est le moins fréquent des cancers de la femme.
- B. Sa fréquence est en cours d'augmentation.
- C. Est un cancer hormono-dépendant
- D. Ne touche jamais l'homme
- E. Le THS augmente son risque

QCM 32

Parmi les facteurs de risque du cancer du sein :

- A. Puberté tardive
- B. Ménopause tardive
- C. Première grossesse tardive
- D. ATCD de dystrophie fibro-kystique
- E. Mère décédée d'un cancer du sein

QCM 33

- Patiente âgée de 36 ans consulte pour une mastodynie, dans ces antécédents familiaux on note une mère ayant présente un cancer du sein dans ces antécédents personnels un cancer de l'ovaire traité et bien contrôlé une puberté avant 11 ans et une multiparité avec un bas niveau socio-économique. Quels sont parmi les facteurs suivants ceux à risques :

A - Antécédent de cancer du sein chez la mère

B - La puberté avant 11 ans

C - Le bas niveau socio-économique

D - Antécédent de cancer de l'ovaire

E – Multiparité

QCM 34

- Parmi les facteurs suivants quel est celui ou quels sont ceux qui sont présent chez une femme a risque de cancer du sein :

A - Prise d'oestrogène par la mère pendant la grossesse

B - Cancer du sein controlatéral

C - Cancer du sein chez la mère

D - Allaitement

E - tout niveau socio-économique

QCM 35

Parmi les facteurs suivants. Lesquels sont considérés comme étant des facteurs de risque du cancer du sein :

- A - Une mère ayant un cancer du sein
- B - Une grande multiparité
- C - Absence d'allaitement au sein
- D - Ménopause tardive
- E - Un cancer du col utérin.

5. Réunir les éléments cliniques et paracliniques permettant de poser le diagnostic du cancer du sein en fonction du degré d'évolution.

QCM 36

Quel est l'examen d'imagerie de référence, utilisé en première intention pour le diagnostic et le dépistage du cancer du sein ?

- A. La mammographie
- B. L'échographie mammaire
- C. L'IRM mammaire
- D. Le PET-scan
- E. La radiographie du thorax

QCM 37

Le cancer du sein :

- A. Est le plus souvent de découverte fortuite
- B. Est souvent découvert par l'autopalpation
- C. Peut découvert par une fracture pathologique
- D. Peut découvert par une atteinte ganglionnaire
- E. Se manifeste souvent par des mastodynies

QCM 38

Le diagnostic du cancer du sein est confirmé par :

- A. La mammographie
- B. L'échographie mammaire
- C. Le couple écho + mammo
- D. La cytologie mammaire
- E. La biopsie

QCM 39

Les signes cliniques de malignité d'un nodule du sein:

- A. Tumeur dure indolore mal limitée
- B. Modification du galbe
- C. Manœuvre de Tillaux sans particularité
- D. Écoulement mamelonnaire sanglant
- E. Un nodule roulant sous les doigts

QCM40

Chez une patiente présente une tuméfaction mammaire. Quel(s) est (sont) parmi les critères radiologiques suivants, celui (ceux) qui fait (font) suspecter le cancer ?

- A- Présence de macro-calcifications isolées
- B- Image radiologique de volume inférieur à celui trouvé à l'examen clinique
- C- Épaississement cutané en regard de la lésion
- D- Présence de micro-calcifications en foyer
- E- Irrégularité de l'opacité

QCM 41

Madame R... vous consulte pour une tuméfaction dans le sein. Vous avez demandé une mammographie. Parmi les signes radiologiques ci-dessous, indiquez celui ou ceux qui vous font penser qu'il s'agit peut-être d'un cancer ?

- A. L'image est mal limitée
- B. L'image fait 1 cm de diamètre, alors que la tumeur palpée fait 3 cm
- C. Il n'y a pas de micro calcifications
- D. La peau en regard de la tumeur est un peu épaisse
- E. On ne voit pas de ganglions

QCM 42

Chez une femme de 35 ans présentant une tumeur du sein de 3cm de diamètre, le seul examen permettant d'affirmer avec certitude le diagnostic de cancer est :

- A. La thermographie
- B. La mammographie
- C. La cytologie
- D. L'examen clinique
- E. Prélèvement pour examen anatomo-pathologique

QCM 43

La mammographie :

- A. Une seule incidence craniocaudale est suffisante
- B. Une opacité stellaire est souvent bénigne à l'histologie
- C. Peut-être faussement rassurante si les seins sont denses
- D. Les micro-calcifications vermiculaires sont très suspectes
- E. N'intéresse pas le prolongement axillaire

QCM 44

L'IRM mammaire est indiquée : devant

- A. Une tumeur inflammatoire du sein
- B. Un Carcinome lobulaire invasif
- C. Un risque génétique élevé (mutation BRCA),
- D. Une adénopathie axillaire sans tumeur visible.
- E. Une récurrence locale

QCM 45

Dans la classification ACR en mammographie, un classement ACR 0

- A. Est une classification d'attente
- B. Nécessité un complément d'exploration
- C. Indique toujours une IRM mammaire
- D. Indique une biopsie mammaire
- E. Indique une deuxième lecture des clichés mammographies

6. Evaluer sur des arguments cliniques et paracliniques le pronostic du cancer du sein.

QCM 46

Parmi les facteurs suivants, lequel est considéré comme un facteur histo-pronostique de mauvais pronostic dans l'évaluation d'un cancer du sein ?

- A. L'absence de surexpression de l'oncogène HER2/neu
- B. La présence de récepteurs aux œstrogènes (RE+)
- C. Un index de prolifération Ki67 supérieur à 20%
- D. Un grade histo-pronostique SBR de I
- E. Un âge de 50 ans

QCM 47

Sur le plan anatomopathologique, le facteur pronostique le plus important est :

- A. L'envahissement ganglionnaire axillaire
- B. Le grade SBR,
- C. La taille de la tumeur
- D. Les récepteurs hormonaux
- E. L'expression de HER2

QCM 48

Le pronostic du cancer du sein dépend de :

- A. La taille tumorale
- B. L'atteinte ganglionnaire
- C. Est plus mauvais chez l'homme
- D. La présence de métastase
- E. Grade SBR

QCM 49

Dans un cancer du sein, la présence de récepteurs hormonaux

- A- A une signification pronostique favorable
- B- Permet de prévoir une bonne chimio sensibilité
- C- Permet de prévoir une bonne hormonosensibilité
- D- Constitue une contre-indication chirurgicale
- E - Indique que la malade est encore réglée

QCM 50

Le pronostic du cancer du sein est fonction

- A. De la taille de la tumeur
- B. D'antécédents de dystrophie mammaire
- C. De la positivité des récepteurs hormonaux dans la tumeur
- D. De l'importance des micro- calcifications sur les clichés de mammographies
- E. De la présence ou de l'absence d'une adhérence cutanée

7. Planifier la stratégie thérapeutique du cancer du sein en fonction du stade TNM et des facteurs histo-pronostiques.

QCM 51

Dans quel contexte la chimiothérapie est-elle qualifiée de 'néoadjuvante' ?

- A. Lorsqu'elle est associée à une thérapie ciblée comme le Trastuzumab.
- B. Lorsqu'elle est administrée avant le traitement local (chirurgie) pour des formes évoluées.
- C. Lorsqu'elle est administrée après la chirurgie pour éliminer les métastases occultes.
- D. Lorsqu'elle est utilisée pour traiter des formes métastatiques d'emblée.
- E. Lorsqu'elle est utilisée pour réduire la taille de la tumeur en vue d'une chirurgie conservatrice

QCM 52

Quelle est la principale finalité de la technique du ganglion sentinelle dans la prise en charge chirurgicale du cancer du sein ?

- A. Éviter un curage axillaire complet si ce ganglion n'est pas envahi.
- B. Repérer une lésion non palpable dans le sein avant une tumorectomie.
- C. Traiter une atteinte ganglionnaire déjà confirmée cliniquement.
- D. Déterminer le type histologique exact de la tumeur mammaire.
- E. Épargner un curage axillaire lors d'un cancer du sein chez une femme enceinte

QCM 53

Selon la classification TNM, un 'carcinome inflammatoire' correspond à quelle catégorie

T ?

A. T4d

B. T4b

C. T4a

D. T4c

E. Tis

QCM 54

La chirurgie conservatrice

- A. Toujours suivie d'une radiothérapie
- B. Est une simple mastectomie
- C. Indiqué pour les tumeurs de 3.5 cm
- D. Est une tumorectomie
- E. Peut être réalisé après une chimiothérapie neoadjuvante

QCM 55

La technique du ganglion sentinelle est indiquée devant :

- A. Tumeurs classé T2
- B. Tumeurs inflammatoires
- C. Tumeurs classé T3
- D. Une adénopathie cliniquement palpable
- E. Un cancer du sein chez une femme enceinte

QCM 56

La chimiothérapie adjuvante est indiquée devant :

- A. Un envahissement ganglionnaire
- B. Une tumeur de 20mm,
- C. Des récepteurs hormonaux négatifs
- D. Des embolies lymphatiques positifs,
- E. Un âge de la patiente à 43 ans.

QCM 57

Le bilan indispensable avant de commencer une chimiothérapie par anthracyclines est :

- A. Un bilan cardiaque
- B. Un bilan hépatique
- C. Un bilan d'hémostase
- D. Un bilan rénal
- E. Un bilan osseux

QCM 58

Dans le cas d'une forme évoluée non opérable (T4), le premier traitement à instaurer est :

- A. Une chimiothérapie néo-adjuvante
- B. Une thérapie ciblée si Her2+
- C. Une radiothérapie
- D. Une analgésie palliative
- E. Une chimiothérapie adjuvante

QCM 59

Le traitement d'un carcinome canalaire in situ (CCIS) avec un foyer de micro calcifications < 3 cm est :

- A. Une Tumorectomie sans curage axillaire, suivie d'une radiothérapie adjuvante.
- B. Une mastectomie suivie d'une radiothérapie
- C. Une intervention de patey
- D. Une Tumorectomie avec curage axillaire
- E. Une chimiothérapie

QCM 60

La prise en charge recommandée pour un carcinome lobulaire in situ (CLIS) après exérèse chirurgicale est :

- A. Une simple surveillance
- B. Une Tumorectomie sans curage axillaire, suivie d'une radiothérapie adjuvante.
- C. Une mastectomie suivie d'une radiothérapie
- D. Une intervention de patey
- E. Une Tumorectomie avec curage axillaire

QCM 61

Le traitement d'une maladie de Paget dépend essentiellement de (cs):

- A. La nature du carcinome sous-jacent
- B. L'âge de la patiente
- C. La taille de la tumeur
- D. Les signes mammographiques
- E. Du nombre des cellules en bagues à chaton

QCM 62

Dans la classification TNM, Tis (Paget) signifie :

- A. Maladie de Paget du mamelon sans tumeur décelable.
- B. Maladie de Paget avec carcinome in situ
- C. Maladie de Paget avec carcinome canalaire infiltrant
- D. Maladie de Paget avec carcinome lobulaire in situ
- E. Maladie de Paget avec carcinome canalaire infiltrant

QCM 63

Une tumeur mesurant 4 cm est classée selon la classification TNM :

- A. T3
- B. T4a
- C. T2
- D. T1
- E. T4b

QCM 64

L'aspect de 'peau d'orange' du sein correspond dans la classification

TNM à :

- A. T3
- B. T4a
- C. T4b
- D. T4c
- E. T4d

QCM 65

Des ganglions axillaires homolatéraux mobiles chez une femme atteinte de cancer du sein correspondent dans la classification TNM clinique au :

- A. Stade N1
- B. Stade N2
- C. Stade N3a
- D. Stade N3b
- E. Stade N3c

QCM 66

La présence de métastases ganglionnaires dans les ganglions sus-claviculaires homolatéraux correspond dans la classification TNM clinique au :

- A. Stade N1
- B. Stade N2
- C. Stade N3a
- D. Stade N3b
- E. Stade N3c

QCM 67

Une chirurgie conservatrice pour cancer du sein ne peut être réalisée que si :

- A. Femme jeune
- B. Taille tumorale < 3cm
- C. Atteinte ganglionnaire
- D. La recoupe est saine après tumorectomie
- E. Atteinte multicentrique

QCM 68

Le traitement général pour cancer du sein est toujours indiqué si :

- A. Formes inflammatoires
- B. Age jeune
- C. Formes métastatiques
- D. Traitement conservateur avec atteinte ganglionnaire
- E. Formes inopérables

QCM 69

Le traitement chirurgical d'un cancer du sein:

- A. La mastectomie est indiquée si tumeur > 3cm
- B. La tumorectomie est possible en présence de deux lésions malignes d'1cm du sein gauche
- C. Le curage ganglionnaire n'est pas indiquée si lésion maligne < 1cm
- D. Ganglion sentinelle est possible si tumeur maligne < 2cm
- E. Nécessite la résection des muscles pectoraux

QCM 70

La radiothérapie pour cancer du sein

- A. Systématique en cas de tumorectomie
- B. Intéresse les aires axillaires après curage positif
- C. Intéresse les aires mammaires internes si lésions des quadrants internes
- D. N'est pas nécessaire en cas de mastectomie
- E. Vise à réduire le risque de métastase

8. Indiquer les modalités de surveillance post-thérapeutique d'un cancer du sein.

QCM 71

La surveillance d'un cancer du sein traité fait appel à

- A. Un examen clinique tous les trois mois pendant deux ans
- B. Une mammographie à 6 mois puis tous les ans
- C. Une échographie pelvienne annuelle pour les femmes sous tamoxifène
- D. Une échographie hépatique annuelle
- E. Un scanner cérébrale tous les deux ans

QCM 72

Quelle surveillance spécifique est recommandée pour une patiente sous Tamoxifène, en plus du suivi sénologique habituel ?

- A. Une échographie hépatique annuelle
- B. Une écho-doppler des membres inférieurs
- C. Un examen gynécologique avec échographie pelvienne
- D. Une ostéodensitométrie tous les deux ans
- E. Un scanner cérébrale tout les trois ans

QCM 73

Après traitement d'un cancer du sein une femme vous consulte pour surveillance il faut alors pratiquer chez elle :

A - Une palpation du sein restant ,du foie et de l'abdomen

B - Un dosage de L'ACE et CA 15 -3

C - Un radiographie pulmonaire

D - Un dosage de BHCG

E - Une mammographie du sein restant.

9.Elaborer la stratégie du diagnostic précoce du cancer du sein.

QCM 74

Une patiente ne présentant aucun facteur de risque épidémiologique de cancer du sein doit bénéficier :

- A - Un examen clinique annuel à partir de 30 ans
- B - Une mammographie tous les 6 mois
- C - Un enseignement de l'autopalpation des seins
- D - Une mammographie au premier signe d'appel
- E - Une mammographie tous les 3 ans à partir de 50 ans.

QCM 75

Le dépistage du cancer du sein

A-Commence à 35 ans

B- Se fait par deux clichés de mammographie

C-Se fait tous les ans si elle est normale

D- Est plus précoce en cas d'ATCD familiaux de cancer du sein

E-Se fait par échographie mammaire

Early Detection Strategies



Regular Screening

Perform self-exams and schedule mammograms.



Genetic Testing

Identify high-risk individuals for early intervention.



Lifestyle Changes

Maintain a healthy diet and exercise routine.

10. Expliquer les moyens de prévention du cancer du sein.

QCM 76

Parmi les moyens de prévention primaire du cancer du sein on cite :

- A. Contrôler son poids,
- B. Limiter les graisses animales et l'alcool,
- C. Pratiquer une activité sportive régulière,
- D. Allaiter
- E. Prendre quotidiennement 100mg d'acide salicylique

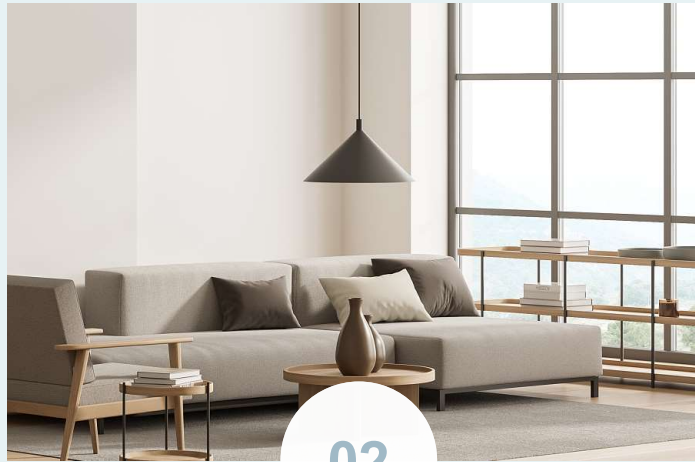
Lifestyle Changes



01

Maintain a Healthy Weight

Maintain a healthy body weight to reduce breast cancer risk.



02

Limit Alcohol

Consumption
Reduce alcohol intake to lower breast cancer risk.



03

Exercise Regularly

Engage in regular physical activity to promote breast health.

Genetic Testing and Counseling

01

Early Detection

Genetic testing can identify high-risk individuals for early intervention.

02

Personalized Screening

Counseling guides tailored screening and prevention strategies for at-risk patients.

03

Risk Reduction

Genetic information enables proactive measures to lower breast cancer risk.



CAS CLINIQUE



N1

- Madame M âgée de 55 ans, chercheuse en biologie , vous consulte suite à la découverte d'un nodule du sein droit sous sa douche.
- Elle n'a pas d'antécédents médico chirurgicaux particuliers. Sur le plan gynécologique , elle a eu ses premières ménarche à l'âge de 10 ans puis une contraception oestroprogestative arrêtée il y a 12 ans. Elle est G1P1 avec un accouchement normal à 37 ans et elle n'a pas allaité son enfant. Elle est ménopausée depuis l'âge de 53 ans et prend depuis un traitement hormonal de la ménopause. Sa mère a été traité à l'âge de 50 ans d'un cancer du sein gauche.
- A l'examen vous palpez un nodule dur, mal limité d'un peu moins 2 cm dans le QSED non adhérent aux plans superficiels et profonds . Il n'y a pas de signes inflammatoires . La palpation du creux axillaire droit est sans particularités.



QCM1

Quel(s) examen(s) prescrivez vous dans un premier temps?

- A. Echographie mammaire bilatéral vu l'âge
- B. Mammographie bilatérale avec incidence cranio caudale
- C. IRM mammaire vu les ATCD familiaux
- D. Micro biopsie du nodule
- E. Echo-mammographie bilatérale

L'IRM n'est pas demandée de 1^{ère} intention. Elle a des indications restreintes :

- Caractérisation d'une image écho-mammographique difficile à interpréter (ACR0, ..),
- Recherche d'une lésion mammaire en présence d'une adénopathie axillaire sans anomalie écho-mammographique,
- Carcinome lobulaire invasif (multifocalité et multicentricité et bilatéralité),
- Risque génétique (mutation BRCA),
- Suspicion de récurrence,
- Evaluation de la réponse après chimiothérapie néo adjuvante en vue d'un traitement conservateur
- Femme jeune avant 40 ans
- Prothèse mammaire
- Discordance radio-clinique.



QCM2

Quels sont les facteurs de risque de cancer du sein que vous retrouvez dans cette observation,

- A. SEXE
- B. Age
- C. Contraception oestroprogestative
- D. Première grossesse tardive
- E. Hyperoestrogénie endogène et exogène



QCM3

Vous suspectez un cancer du sein , Comment confirmez votre diagnostic?

- A. Micropsie au pistolet
- B. Biopsie transcutané
- C. Microbiopsie echoguidée
- D. Cytoponction à la recherche des cellules cancéreuse
- E. Macrobiopsie au mammotomes



QCM4

Le diagnostic de cancer est confirmé. Quel est le type histologique le plus souvent rencontré

- A. Adénocarcinome papillaire
- B. Adénocarcinome médullaire
- C. Adénocarcinome de type non spécifique
- D. Adénocarcinome canalaire infiltrant
- E. Adénocarcinome lobulaire infiltrant



QCM5

Comment classez vous cette tumeur selon la classification TNM?

A. T1BNXMX

B. T1CNOMX

C. T2NOMX

D. pT1CpNOMi

E. T2N1MX

ANNEXES : Classification TNM clinique (2017)

1. Tumeur primitive (T)

Tx	Détermination de la tumeur primitive impossible.
T0	Pas de signe de tumeur primitive.
Tis	Carcinome <i>in situ</i>.
Tis (CCIS)	Carcinome canalaire <i>in situ</i> . Dans la classification 2017, le carcinome lobulaire <i>in situ</i> est considéré comme une lésion "bénigne" et est donc exclue de la classification pTNM.
Tis (Paget)	Maladie de Paget du mamelon sans tumeur décelable. <i>Note : une maladie de Paget avec tumeur décelable est à classer en fonction de la taille de la tumeur.</i>
T1	Tumeur ≤ 2 cm dans sa plus grande dimension.
T1mic	Micro-invasion ≤ 0,1 cm dans sa plus grande dimension. <i>Note : La micro-invasion est une extension des cellules cancéreuses, au-delà de la membrane basale sans dépasser 0,1 cm.</i>
T1a	0,1 cm < T ≤ 0,5 cm dans sa plus grande dimension.
T1b	0,5 cm < T ≤ 1 cm dans sa plus grande dimension.
T1c	1 cm < T ≤ 2 cm dans sa plus grande dimension.
T2	Tumeur 2 cm < T ≤ 5 cm dans sa plus grande dimension.
T3	Tumeur >5 cm dans sa plus grande dimension.
T4	Tumeur de toute taille avec extension directe à la paroi thoracique (a) et/ou à la peau (b).
T4a	Extension à la paroi thoracique. <i>Note : la paroi thoracique comprend les côtes, les muscles intercostaux et le grand dentelé mais ne comprend pas le muscle pectoral.</i>
T4b	Œdème (y compris la « peau d'orange ») ou ulcération cutanée du sein ou nodules de perméation cutanés limités au même sein. <i>Il est précisé que l'atteinte cutanée uniquement visible microscopiquement, en l'absence d'ulcération ou de "peau d'orange" clinique, ne doit pas être classée comme T4b mais la tumeur doit être classée seulement en fonction de sa taille.</i>
T4c	A la fois 4a et 4b.
T4d	Carcinome inflammatoire. <i>Note : le carcinome inflammatoire du sein est caractérisé par une induration cutanée diffuse, d'aspect charnu, à bords érysipéloïdes, habituellement sans tumeur palpable sous-jacente.</i>

2. Adénopathies régionales (N)

(Déteclées à l'examen clinique ou radiologique)

Nx	Appréciation impossible de l'atteinte ganglionnaire (du fait, par exemple, d'une exérèse antérieure).
N0	Absence de signe d'envahissement ganglionnaire régional.
N1	Ganglions axillaires de niveau I et II homolatéraux mobiles.
N2	Métastases dans un ou plusieurs ganglions axillaires de niveau I et II homolatéraux fixé(s) ou confluent(s) ou dans un ou plusieurs ganglions mammaires internes homolatéraux cliniquement déteclables en l'absence de métastase ganglionnaire axillaire cliniquement évidente.
N2a	Métastases dans un ou plusieurs ganglion(s) axillaire(s) fixé(s) entre eux (confluents) ou à d'autres structures.
N2b	Métastases cliniquement déteclables uniquement dans les ganglions mammaires internes, et en l'absence de métastase ganglionnaire axillaire cliniquement décelable.
N3	Métastases dans les ganglions sous-claviculaires homolatéraux (niveau III) avec ou sans envahissement ganglionnaire axillaire (niveau I, II) ou métastase ganglionnaire mammaire interne homolatérale cliniquement déteclable en présence de métastase axillaire (niveau I, II) cliniquement évidente ; ou métastases ganglionnaires sous-claviculaires homolatérales avec ou sans envahissement ganglionnaire axillaire ou mammaire interne.
N3a	Métastase(s) ganglionnaire(s) sous-claviculaire(s).
N3b	Métastases ganglionnaires mammaires internes et axillaires.
N3c	Métastase(s) ganglionnaire(s) sus-claviculaire(s).

* Cliniquement déteclable signifie : déteclé par un examen clinique ou par l'imagerie (lymphoscintigraphie exclue) et présentant des caractéristiques hautement suspectes de malignité, ou suspicion histopathologique de macrométastase fondée sur l'analyse cytologique d'un prélèvement par cytoponction.

3. Métastases à distance (M)

MX	Renseignements insuffisants pour classer les métastases à distance
M0	Absence de métastase à distance
M1	Présence de métastase(s) à distance

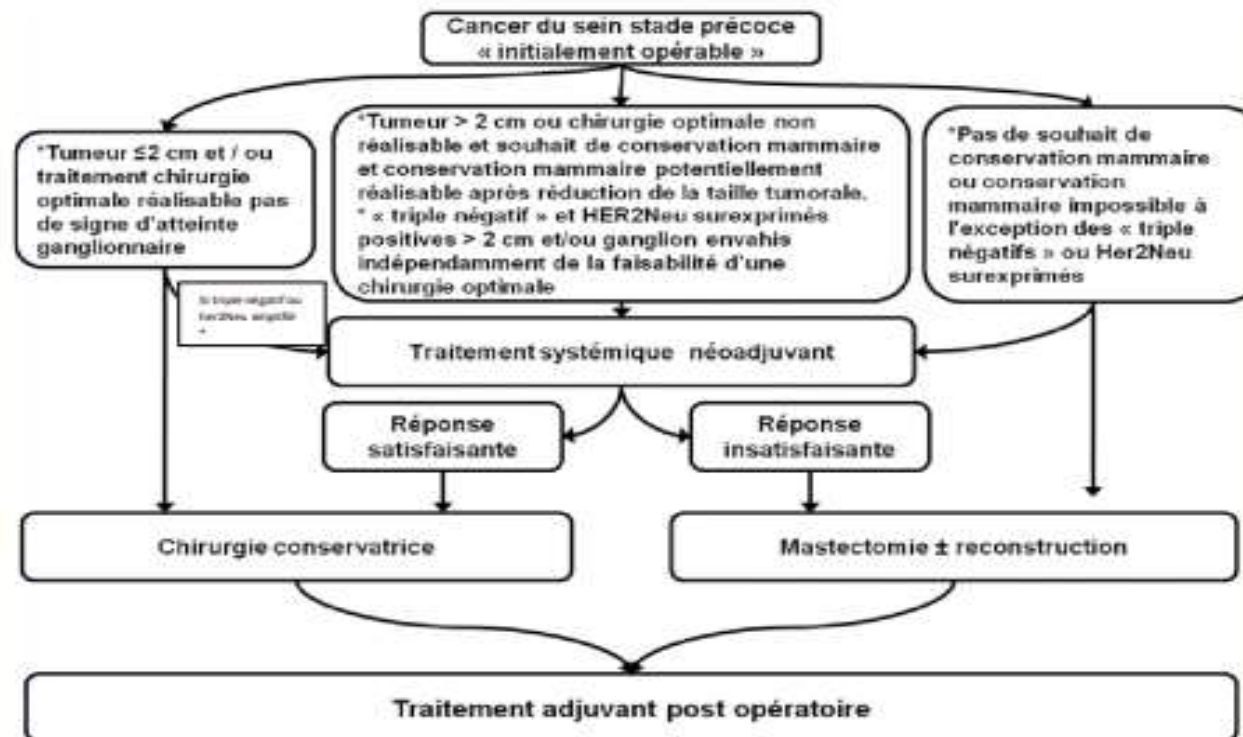
QCM6

Quelle est votre prise en charge thérapeutique

- A. Patey puisque il ya des ATCD Familiaux
- B. tumorectomie du sein droit avec examen extemprané et curage axillaire
- C. tumorectomie et technique du ganglion sentinelle
- D. Polychimiothérapie néoadjuvante
- E. Arret de THM

1. Formes opérables d'emblée : T1-T2-T3, N0-N1, M0

a. Traitement chirurgical initial :



- Irradiation locorégionale systématique si :

1. Traitement conservateur
2. Curage axillaire positif (N+)
3. Chirurgie radicale + curage axillaire négatif (N-) SI
 - pT3
 - pT4
 - ou présence de deux facteurs de mauvais pronostic : âge <40 ans, taille tumorale ≥ 2 cm, SBR III, multifocalité macroscopique, profil IHC triple négatif(basal), présence d'embolies ou d'engainement péri-nerveux.

- Chimiothérapie adjuvante si facteurs de mauvais pronostic :

N+, Grade SBR II/III, jeune âge, récepteurs hormonaux négatifs, surexpression du gène HER2neu, T > 2cm

- Hormonothérapie si RH positifs.
- Trastuzumab si surexpression de Her2neu.

QCM7

Il s'agit finalement d'un cancer infiltrant de 1.3 cm de plus grand axe de grade 3 avec Ki67% à 70%, présence d'embols péritumoraux, présence de récepteurs hormonaux et surexprimant HER2Neu. Les marges de résection sont saines. On note la présence de micrométastase ganglionnaire.

Le bilan d'extension est négatif. Quel est le stade TNM de cette tumeur?

A. pT1bpN1M1

B. pT1cpNiMX

C. pT1cpN1MX

D. pT1pN0M0

E. pT1cpn



QCM8

Quelle est la classe moléculaire de cette tumeur?

A. Luminal A

B. LuminalB

C. Triple négatif

D. HER 2neu surexprimé

E. Profil indéterminé

Critères	Luminal A	Luminal B	Her2	Triple négatif(basal)
IHC	RE+/RP+ Her2- Ki67 < 20%	RE+/RP+/Her2+ Ou RE+/RP+/Her2- /Ki67>20%	RE-/RP- Her2 +	RE-/RP- Her2-
Cliniques	Bonne réponse à l'hormono-thérapie Bon pronostic	Réponse variable Plutôt chimiothérapie	Haut grade souvent N+ Bonne réponse à la thérapie ciblée	Haut grade Mauvais pronostic



QCM9

Quel bilan d'extension réalisez vous?

- A. Examen clinique
- B.TDM TAP et PETTDM
- C.TDM TAP et SCINTIGRAPHIE OSSEUSE
- D. Marqueurs tumoraux
- E.PET TDM



Devant tout cancer du sein un bilan d'extension est indiqué. Il est locorégional et à distance. Le bilan d'extension est fait de :

- Examen clinique
- Une imagerie n'est pas systématiquement indiquée pour les tumeurs cT1N0, cT2N0. Elle peut être demandée en cas de doute ou de tumeur potentiellement agressive.
- Un scanner thoraco-abdomino-pelvien et une scintigraphie osseuse : le cancer du sein est un cancer ostéophile. Les sites métastatiques les plus fréquents sont : l'os, le foie, le poumon et le cerveau.
- Idéalement un PET-scan peut remplacer le bilan d'extension.

QCM10

Quels sont les facteurs de mauvais pronostic du cancer du sein?

A. Grade

B. Présence d'embols vasculaires péri-tumoraux

C. Tumeur proliférante et statut ganglionnaire

D. Surexpression HER2Neu

E. Age



N °2

- Mme E, âgée de 46 ans ,agrégée en philosophie vous consulte pour une boule d'apparition récente au niveau du sein droit.
- Cette patiente a eu ses ménarche à l'âge de 10 ans.Elle a utilisé une COP par pillule pendant 10 ans avant une première grossesse à 39 ans avec allaitement artificiel .Elle est ménopausée depuis 2 ans et prend un THM depuis.Sa sœur aînée est décédée par un cancer de colon et sa mère est suivie pour un cancer de l'endomètre et sa cousine ayant cancer du sein traité par tumorectomie avec ganglion sentinelle.



Cette patiente pèse 85 kg pour 1.67 m. Vous palpez au niveau du sein droit un placard rétroaréolaire de 2 cm associé à une rétraction du mamelon ainsi qu'une ADP homolatérale axillaire suspecte. Le reste de l'examen est sans particularités.

- Echo mammographie retrouve une opacité du QSE droit de 24 mm de grand axe classée ACR5. L'échographie a montré un cône d'ombre post en arrière de cette masse.



QCM1

Que signifie ACR5?

A.C'est un cancer du sein

B.Lésion nécessitant une biopsie

C.Lésion nécessitant une surveillance radiologique rapprochée

D.lésion évocatrice de cancer du sein

E.Cancer du sein de mauvais pronostic

		ACR 1 (normale) ACR2 (bénin)	ACR3 (probablement bénin)	ACR4 (suspect)	ACR 5 (fortement évocateur)
Opacité	Taille	Idem palpation		Plus petite que palpation, polylobaire	
	Densité	Homogène		Hétérogène, centre dense	
	Contours	Réguliers		Polylobés, Irréguliers, spiculés, mal limités, stellaire	
Rétraction cutanée en regard		0		+	
Calcifications		Annulaires, punctiformes, cupuliformes		Vermiculaires, irrégulières Groupées en foyers	
Architecture		Organisée		Désorganisée	
CAT		<i>Pas de surveillance</i>	<i>Mammographie M6</i>	<i>Histologie nécessaire ++</i>	



QCM 2

Concernant le traitement chirurgical initial de cette patiente, la patiente souhaite un traitement conservateur comme sa cousine; Vous lui répondez

- A. Possible
- B. Contre indiqué
- C. Le traitement radical est indiqué dans son cas vu les ATCD familiaux
- D. Le curage axillaire est indiqué
- E. Chimiothérapie néoadjuvante puis ganglion sentinelle



QCM3

Quels sont les facteurs de risque de cancer du sein que vous retrouvez dans cette observation?

- A. Mutation BRCA1
- B. Syndrome de Lynch
- C. Niveau socioéconomique élevé
- D. Obésité
- E. Traitement hormonal de la ménopause



QCM4

Vous décidez d'opérer cette patiente. Quels renseignements attendez vous du compte rendu définitif?

- A. Type histologique
- B. Taille
- C. caractère multifocal ou multicentrique ,bilatéral
- D. Grade histologique de la tumeur
- E. Présence d'embols vasculaires péri-tumoraux



QCM5

Sur le compte rendu d'anatomopathologie ;vous lisez 11N+/16;Cela signifie que

- A. Le nombre de ganglions prélevé est insuffisant
- B. 11 ganglions atteints sur 16 ganglions
- C. 16 ganglions atteints
- D. Mauvais pronostic
- E. Effraction capsulaire ganglionnaire



QCM6

La patiente est a haut risque métastatique parce que

- A. la tumeur est volumineuse
- B. Envahissement ganglionnaire
- C. ATCD familiaux
- D. Age
- E. Sexe féminin



QCM 7

La patiente a eu un curage axillaire; Quels sont les complications possibles

- A. Plaie de la artère axillaire
- B. Plaie du pédicule vasculonerveux du grand dorsal
- C. Hématome axillaire
- D. Lymphocèle
- E. Troubles neurologiques sensitifs et algodystrophie



QCM8

La patiente va bénéficier d'une poly chimiothérapie selon le protocole FEC100, quelles drogues désignez vous?

- A. 5 FU
- B. Epirubicine
- C. Cyclophosphamide
- D. Sels de platine
- E. Anthracyclines



Les produits utilisés sont schématiquement les suivants : - Les inhibiteurs de type isomérases II dont les plus utilisés sont les

- anthracyclines.
- alkylants, en particulier le cyclophosphamide.
- anti-métabolites, en particulier le 5 fluoro-uracile.
- antimitotiques : les alcaloïdes de la pervenche et les taxanes.



QCM9

Quels en sont les principaux effets indésirables de la chimiothérapie?

- A. Infertilité
- B. Dépression médullaire
- C. Hyperuricémie
- D. Hypokaliémie
- E. Péricardite

- Bilan pré chimiothérapie :

- ECG
- Echo-cardiaque (avec Fraction d'éjection du VG) [anthracyclines → toxicité cardiaque]
- Bilan biologique
- Pose de site implantable
- Préservation de la fertilité chez la femme jeune

Cas clinique QCM N°3

- Madame K âgée de 36 ans .Elle n'a pas d'ATCD médicochirurgicaux particuliers. Elle est la mère de 2 enfants qui sont maintenant âgé de 12 ans. Elle prend une COP par pilule qu'elle tolère bien. Elle a arrêté de fumer depuis 10 ans a peu près. C'est une femme sportive .Elle a une mère décédée par cancer du sein à l'âge de 40 ans.
- A l'examen des seins de routine vous constatez un nodule de sein droit indurée de 2 cm au niveau du QSED. L'examen des aires axillaires est sans anomalies.
- A l'Echomammographie :opacité isolée de 16 mm classé ACR4.
- Histologie: Adénocarcinome de type non spécifique



QCM1

Quel est votre PEC initiale?

- A. Chimiothérapie néo adjuvante
- B. Traitement conservateur avec curage axillaire
- C. Tumorectomie avec technique du ganglion sentinelle
- D. Arrêt de la pilule OP
- E. Prise en charge psychologique



QCM2

Pendant l'intervention chirurgicale, l'analyse anatomopathologique extemporanée du ganglion sentinelle conclut à son envahissement tumoral; Quelle est votre conduite

- A. Radiothérapie adjuvante
- B. Chimiothérapie adjuvante
- C. Irradiation sur le creux axillaire
- D. Curage axillaire
- E. Compléter par une mastectomie



QCM3

A l'Anapath: Adénocarcinome de type non spécifique de 18mm ,les marges sont insuffisantes au niveau de la limite interne de la pièce opératoire avec des embols tumoraux, RH+;2N+/12,HER2neu négatif

Quel est votre PEC?

- A. Bilan oncogénétique
- B. Reprise chirurgicale
- C. Polychimiothérapie
- D. Herceptine
- E. Radiothérapie adjuvante



QCM4

Quelques jours après la sortie de cette patiente, elle revient vous voir en urgence pour l'apparition d'une volumineuse tuméfaction du creux axillaire droit, qui est indolore sans signes inflammatoire en regard

Vous suspectez

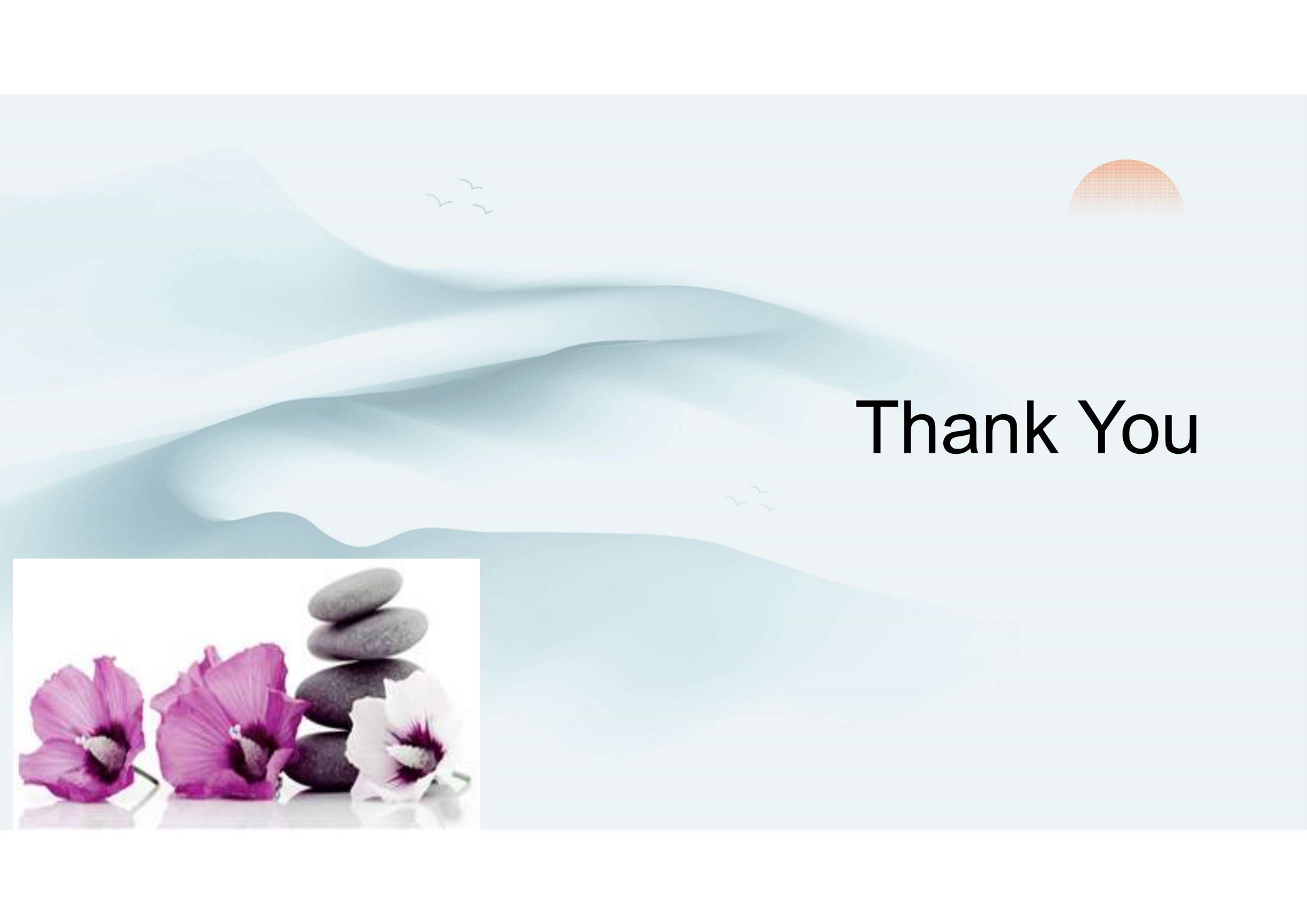
- A. Infection du site opératoire
- B. Oedème
- C. Lymphocèle
- D. Lymphoedème
- E. Hématome pariétal



QCM5

Quelle thérapie adjuvante vous proposez:

- A. Trastuzumab
- B. Hormonothérapie
- C. Inhibiteur PARP
- D. Inhibiteurs CDK/6
- E. Olaparib

The background features a minimalist, artistic illustration of a landscape. It includes soft, blue-toned mountains or hills, a pale blue sky, a small orange sun rising on the right, and a few small birds in flight.

Thank You

